

Motif de consultation	
Suivi de son diabète et de son hypertension artérielle, ainsi que pour des œdèmes aux chevilles	
Historique médical	
Antécédents	
Antécédents médicaux	diabète, cholestérol élevé, hypertension
Antécédents familiaux	crise cardiaque du père à 68-69 ans, tension élevée de la mère
Mode de vie	arrêté il y a 20 ans ; un verre de vin le soir, un peu de vin le week-end ; peu d'activité physique, marche le mercredi avec sa femme ; retraité, plus sédentaire
Traitements habituels	Périndopril 4 mg le matin ; Metformine 1000 mg matin et soir ; Atorvastatine 40 mg le soir
Allergies	Aucune allergie connue
Interrogatoire	
Symptômes généraux	œdèmes aux chevilles, essoufflement
Symptômes spécifiques	douleur aux chevilles, essoufflement lors de la montée des escaliers
Détails additionnels	Le patient a des œdèmes aux chevilles, surtout le soir après une journée debout, et une légère essoufflement lors de l'effort. Il prend actuellement du pérendopril pour l'hypertension, de la metformine pour le diabète et de l'atorvastatine pour le cholestérol. Il a arrêté de fumer il y a 20 ans et boit un verre de vin le soir. Il a des antécédents familiaux de crise cardiaque et d'hypertension
Examen clinique	
Selon spécialité (ORL)	ECG recommandé
Observations	La tension artérielle est à 148/86 mmHg, ce qui est un peu élevé. Le patient a une HBA1c à 7,8%, ce qui est légèrement élevé. Il a également des œdèmes aux chevilles
Conclusion	
Diagnostic	hypertension, diabète, cholestérol élevé
Proposition thérapeutique	ajout de l'Indapamide 1,25 mg le matin, surveillance de la glycémie et de la pression artérielle
Traitement recommandé	Ajout d'indapamide 1,25 mg le matin pour aider à éliminer l'eau en excès et améliorer la tension artérielle. Renouvellement des traitements actuels (pérendopril, metformine, atorvastatine). Réalisation d'un ECG pour vérifier le fonctionnement cardiaque. Suivi dans 3 semaines pour vérifier les résultats des examens et ajuster les traitements si nécessaire

Examens complémentaires	ECG, prise de sang pour vérifier les ions et la créatinine
Orientation	suivi en consultation dans 3 semaines
Prochaine consultation dans 3 semaines	